TEMA 26 · Cuidados de enfermería en la gestante y la puérpera. Educación maternal. Lactancia natural

Resumen OPE Enfermería SMS · Cambios fisiológicos, nutrición, higiene, vacunas y profilaxis anti-D, educación maternal, hiperémesis, preeclampsia, diabetes gestacional, puerperio (involución, HPP, loquios, BUBBLE-HE, Edimburgo), lactancia (fisiología, leche, técnica, IHAN) y complicaciones

1. Cambios fisiológicos del embarazo

- **hCG** mantiene el cuerpo lúteo; **progesterona** relaja el músculo liso (útero, vasos, cardias: **pirosis**, uréteres, vesícula, intestino: **estreñimiento**); **estrógenos**: crecimiento uterino y ductal, retención de sodio y agua; **relaxina**: laxitud pélvica (dolor púbico, lumbalgia).
- **Cardiovascular**: **volemia +40-50%**; el plasma aumenta más que los hematíes → **anemia fisiológica dilucional**; gasto cardiaco máximo hacia las **semanas 24-28**; la **TA baja** en los dos primeros trimestres (sobre todo la diastólica). **Decúbito lateral izquierdo** (evita la compresión de la cava).
- **Respiratorio**: el diafragma sube 4 cm; **volumen corriente +40%**; **hiperventilación** por progesterona → **alcalosis respiratoria leve**.
- **Renal**: filtrado glomerular **+50%** → **creatinina y urea bajas** (una creatinina de 0,9-1 mg/dl ya es anormal); **hidronefrosis fisiológica**, más **derecha**; **glucosuria** y mayor riesgo de bacteriuria y pielonefritis.
- **Piel**: **cloasma** (70%), **línea nigra**, arañas vasculares, eritema palmar. **Hipercoagulabilidad** (fibrinógeno y factores VII, VIII, IX, X altos): riesgo de **TVP × 5**, máximo en el **puerperio**.

2. Nutrición e higiene

IMC previo	Ganancia total	Semanal (2.º-3.º trimestre)
Bajo peso (< 18,5)	12,5-18 kg	0,5 kg
Normopeso (18,5-24,9)	**11,5-16 kg**	**0,4 kg**
Sobrepeso (25-29,9)	7-11,5 kg	0,3 kg
Obesidad (≥ 30)	5-9 kg	0,2 kg

- Energía: **1.er trimestre +0 kcal**; 2.º **+340**; 3.º **+452 kcal/día** (no "comer por dos"). Proteínas ≈ 12% (la mitad de alto valor biológico); **DHA** (pescado azul **pequeño**: sardina, boquerón); **evitar pez espada, atún rojo, tiburón y lucio** (**mercurio**).
- **Ácido fólico**: desde **1-3 meses antes** hasta la **semana 12**: **0,4 mg/día** (general) o **5 mg/día** (alto riesgo: antecedente de defecto del tubo neural, **diabetes pregestacional**, obesidad, malabsorción, **antiepilépticos**). **Hierro 27-30 mg/día** (con vitamina C), **yodo** (el feto depende de la tiroxina materna en la primera mitad) y calcio.
- **Toxoplasma** (seronegativas): no carne cruda ni embutidos poco curados; lavar frutas y verduras. **Listeria**: no lácteos sin pasteurizar, quesos blandos, patés refrigerados ni ahumados en frío.
- Higiene bucal y dentista (**2.º trimestre**, el más seguro); hidratación de la piel y **fotoprotección** (cloasma); ropa holgada; calzado con **tacón ancho de 2-4 cm**; dormir en **decúbito lateral izquierdo**. Ejercicio moderado ≈ 30 min/día. **Relaciones sexuales permitidas** salvo amenaza de parto prematuro, placenta previa sangrante o rotura de membranas. **Alcohol y tabaco: tolerancia cero**.
- Controles: captación **antes de la semana 12**; **O'Sullivan en las semanas 24-28**; **estreptococo del grupo B** (exudado vaginorrectal) en las **semanas 35-37**.
- **Vacunas**: **prohibidas las vivas** (triple vírica, varicela, fiebre amarilla); **Tdpa en cada embarazo** (semanas **27-36**, ideal 27-28), **VRS** (semanas 24-36), **gripe** y COVID-19 en cualquier trimestre.
- **Profilaxis anti-D** (gestante **Rh negativa** con **Coombs indirecto negativo**): **gammaglobulina anti-D 300 µg** en la **semana 28**, tras el parto **antes de 72 h si el recién nacido es Rh positivo**, y ante eventos sensibilizantes (amniocentesis, aborto, ectópico, traumatismo, versión). Coombs **indirecto**: suero materno; **directo**: hematíes del recién nacido.

3. Educación maternal

- **Preparación al nacimiento y la crianza**: unas **8 sesiones** de 2 h, desde la **semana 28** (máxima receptividad); teoría, dinámicas y **entrenamiento psicofísico**.
- Contenidos: bienestar en el embarazo, parto (pródromos, **dilatación, expulsivo** —nacimiento— y **alumbramiento** —placenta—), analgesia epidural y métodos no farmacológicos (agua, pelota o **esferodinamia**, movimiento), cesárea, puerperio (loquios, **episiorrafia**), tristeza frente a depresión posparto, **lactancia** (enganche asimétrico), cuidados del recién nacido (**cordón con agua y jabón y seco**, sueño seguro, piel con piel).
- Respiraciones: abdominal, torácica y **jadeante** (para **no empujar antes de la dilatación completa**). **Kegel** y **masaje perineal** en las últimas semanas (reduce episiotomías y desgarros).

4. Problemas de la gestación

- **Hiperémesis gravídica** (≈ 2%): vómitos incoercibles con **pérdida > 5% del peso**, **cetonuria**, hipopotasemia, hiponatremia y **alcalosis metabólica**; más frecuente con hCG alta (**gestación múltiple, mola**). Riesgo de **encefalopatía de Wernicke** (**tiamina**). Cuidados: balance hídrico, peso diario, dieta absoluta y sueroterapia, reintroducción con tomas **pequeñas, sólidas y frías**; **doxilamina + piridoxina**; en el hospital metoclopramida u ondansetrón.
- **Preeclampsia**: **TA ≥ 140/90 después de la semana 20** con **proteinuria ≥ 300 mg/24 h** o daño de órgano. **Grave**: **≥ 160/110**, cefalea, **escotomas**, hiperreflexia, **dolor epigástrico** o en hipocondrio derecho, transaminasas al doble, creatinina > 1,1, oliguria, **plaquetas < 100.000**. **Eclampsia** = convulsiones. Cuidados: **habitación tranquila y oscura**, constantes, reflejos, sondaje y diuresis horaria.
- **Sulfato de magnesio** (prevención de la eclampsia): vigilar **frecuencia respiratoria > 12**, **reflejo rotuliano presente** y **diuresis > 30 ml/h**; antídoto: **gluconato cálcico** a pie de cama.
- **Diabetes gestacional**: resistencia a la insulina por el **lactógeno placentario**. **O'Sullivan** (50 g, sin ayuno) **≥ 140 mg/dl a la hora → sobrecarga oral de 100 g** de 3 h (ayuno 8-10 h y 3 días de dieta rica en hidratos): límites **105, 190, 165 y 145 mg/dl**; **≥ 2 valores alterados = diabetes gestacional**; 1 = intolerancia (repetir en 3-4 semanas). Riesgo fetal: **macrosomía** (hiperinsulinismo fetal) y retraso de la maduración pulmonar. Objetivos: **basal < 95** y **1 h tras comer < 140**; si no se controla con dieta y ejercicio, **insulina** (no cruza la placenta). NANDA: **riesgo de nivel de glucemia inestable**.
- **Síndrome HELLP** (complicación de la preeclampsia grave): **H**emólisis, **EL**evación de enzimas hepáticas y **L**ow **P**latelets (plaquetopenia); dolor en epigastrio o hipocondrio derecho.
- **Fecha probable de parto** (regla de **Naegele**): **FUR − 3 meses + 7 días + 1 año** (≈ 280 días). **Maniobras de Leopold**: 4 pasos de palpación abdominal para conocer **situación, presentación, posición** y encajamiento.
- **Hemorragias del 1.er trimestre**:
- **Aborto**: interrupción **antes de la semana 22 o < 500 g**; la causa más frecuente de sangrado en el 1.er trimestre. **Amenaza** (sangrado leve, **cuello cerrado**, embrión vivo), en curso o inevitable (**cuello abierto**), incompleto, completo, **diferido** (embrión muerto retenido), séptico. **Aborto de repetición**: **≥ 2-3 consecutivos**. Tras un aborto en Rh negativa: **anti-D**.
- **Embarazo ectópico**: lo más frecuente en la **ampolla de la trompa**; tríada **amenorrea + dolor abdominal + sangrado escaso**; si se rompe: **shock hemorrágico** (cirugía). Sin rotura y estable: expectante o **metotrexato**.
- **Mola hidatiforme**: proliferación del trofoblasto (vesículas «en racimo de uvas»), **útero mayor que la amenorrea**, **β-hCG muy alta** e hiperémesis; legrado por aspiración y **seguimiento de la β-hCG** (evitar embarazo durante el seguimiento, ≈ 6-12 meses); puede evolucionar a **coriocarcinoma**.
- **Hemorragias del 3.er trimestre**:

	Placenta previa	**Desprendimiento prematuro (DPPNI)**
Inicio	Insidioso	**Brusco**
Dolor	**Indolora**	**Dolor intenso**, constante
Sangre	**Roja, abundante**, recidivante	**Oscura y escasa** (puede quedar oculta)
Útero	**Blando**, se palpa el feto	**Hipertonía** («útero de madera»)

	Placenta previa	Desprendimiento prematuro (DPPNI)
Feto	Sin sufrimiento al principio	**Sufrimiento fetal** precoz
Factores	Multíparas, cesáreas previas	**HTA/preeclampsia**, tabaco, **cocaína**, traumatismo

- En la placenta previa **nunca tacto vaginal** (ecografía); la **oclusiva** (total o parcial) termina en **cesárea**.
- **Molestias**: lumbalgia (relaxina): postura, calor local, calzado, báscula pélvica; NANDA dolor agudo. **Paracetamol**, el analgésico seguro en todo el embarazo.

5. Puerperio

- Desde el alumbramiento hasta la recuperación (**6-8 semanas**): **inmediato** (primeras **24 h**, máximo riesgo de hemorragia), **clínico o mediato** (días 2-10) y **tardío** (hasta los 40-45 días).
- **Globo de seguridad de Pinard**: útero duro a la altura del ombligo, que actúa como **ligaduras vivas**; desciende 1-2 cm/día y **deja de palparse hacia el día 10**. **Entuertos**: más intensos en **multíparas** y al amamantar (**oxitocina**).
- **Hemorragia posparto**: clásicamente > 500 ml (vaginal) o > 1.000 ml (cesárea); actualmente **≥ 1.000 ml** o cualquier pérdida con **inestabilidad**. **4T**: **Tono** (atonía, **70%**: útero blando; **masaje** y uterotónicos), **Trauma** (20%: desgarros; **sangra con útero contraído**), **Tejido** (restos, acretismo) y **Trombina** (coagulopatías).
- **Loquios**: **rubra** (días 1-3/4, rojos; coágulos no mayores que una nuez), **serosa** (días 4-10, rosados o marrones) y **alba** (desde la 2.ª semana, blanquecinos). **Olor fétido = endometritis**. Diuresis y sudoración profusas.
- **BUBBLE-HE**: mamas, útero, intestino, **vejiga** (orinar en **6 h**; un **globo vesical desplaza el útero hacia arriba y a la derecha** y favorece la atonía: **vaciar la vejiga**), loquios, **episiotomía** (escala **REEDA**: enrojecimiento, edema, equimosis, secreción y aproximación), signos de **TVP** (Homans, poco sensible) y estado emocional.
- **Tristeza puerperal (*blues*)**: la más frecuente (hasta el 80%), **días 3-5**, se resuelve en **< 2 semanas**. **Depresión posparto** (10-15%): > 15 días, anhedonia, culpa. **Psicosis puerperal**: **emergencia** (delirios, alucinaciones; riesgo de suicidio e infanticidio): ingreso urgente.
- **Escala de Edimburgo (EPDS)**: 10 ítems sobre los **últimos 7 días**, 0-30 puntos; **≥ 10 = riesgo**; **cualquier puntuación distinta de 0 en el ítem 10** (autolesión) → **derivación urgente en < 24 h**.

6. Lactancia natural

- La succión estimula el hipotálamo y quita el freno de la **dopamina** (factor inhibidor): **prolactina** (**adenohipófisis**: **producción**, para la siguiente toma) y **oxitocina** (**neurohipófisis**: **eyección**). El **estrés** (adrenalina) bloquea la salida de la leche, no su producción.
- **Calostro** (días 1-5): amarillo (betacarotenos), rico en **IgA secretora**, lactoferrina y células; laxante (expulsa el meconio y reduce la ictericia). **Transición** (días 5-14): más volumen, lactosa y grasa. **Madura** (> 14 días): **88% agua** (no dar agua ni infusiones). En la toma, la leche final es la **más grasa y saciante**: no limitar el tiempo.
- **Técnica**: **piel con piel** inmediato e ininterrumpido; bebé alineado (cabeza, cuello y tronco rectos), "ombligo con ombligo"; **boca muy abierta (> 120°)**, labios evertidos, **mentón pegado al pecho y nariz libre**, **más areola visible por encima del labio superior** (**agarre asimétrico**); deglución audible. Si duele, **romper el vacío con un dedo en la comisura** y recolocar. Evitar chupetes y tetinas al inicio (**confusión de tetina**).
- **10 pasos de la IHAN** (OMS/UNICEF): política escrita, formación del personal, información prenatal, **piel con piel al menos 2 h** y primera toma, enseñar a amamantar y la **extracción manual**, **lactancia exclusiva** salvo indicación médica, **alojamiento conjunto 24 h**, **lactancia a demanda** (el llanto es un signo **tardío** de hambre), sin biberones, tetinas ni chupetes, y **grupos de apoyo** al alta.

Complicación	Claves	Actuación
Grietas	Agarre superficial (principal causa de abandono)	**Corregir el agarre**, gotas de leche, postura en "caballito"; no alcohol ni jabones
Ingurgitación	Bilateral, edema, mama pétrea	**Frío**, **presión inversa suavizante**, ibuprofeno; no calor intenso
Mastitis	**Unilateral**, **fiebre > 38,5 °C**, eritema en cuña; *S. aureus*	**No suspender la lactancia** (vaciar), antibiótico, frío; si persiste, descartar **absceso**

- Otras complicaciones: **inversión uterina** (tracción del cordón; hemorragia y shock con **bradicardia**; dos vías, no despegar la placenta), **acretismo** (cesáreas previas; hemorragia masiva, histerectomía), **TVP y embolia** (máximo riesgo en el puerperio; **tríada de Virchow**; deambulación precoz), **hemorragia tardía** (24 h-6 semanas: restos, subinvolución; loquios que vuelven a ser rojos) y **endometritis** (fiebre, útero doloroso, loquios fétidos). **Fiebre puerperal**: > 38 °C en dos tomas, **excluidas las primeras 24 h**.

TRAMPAS DE EXAMEN

! La anemia del embarazo es **dilucional**; la creatinina baja es lo normal.

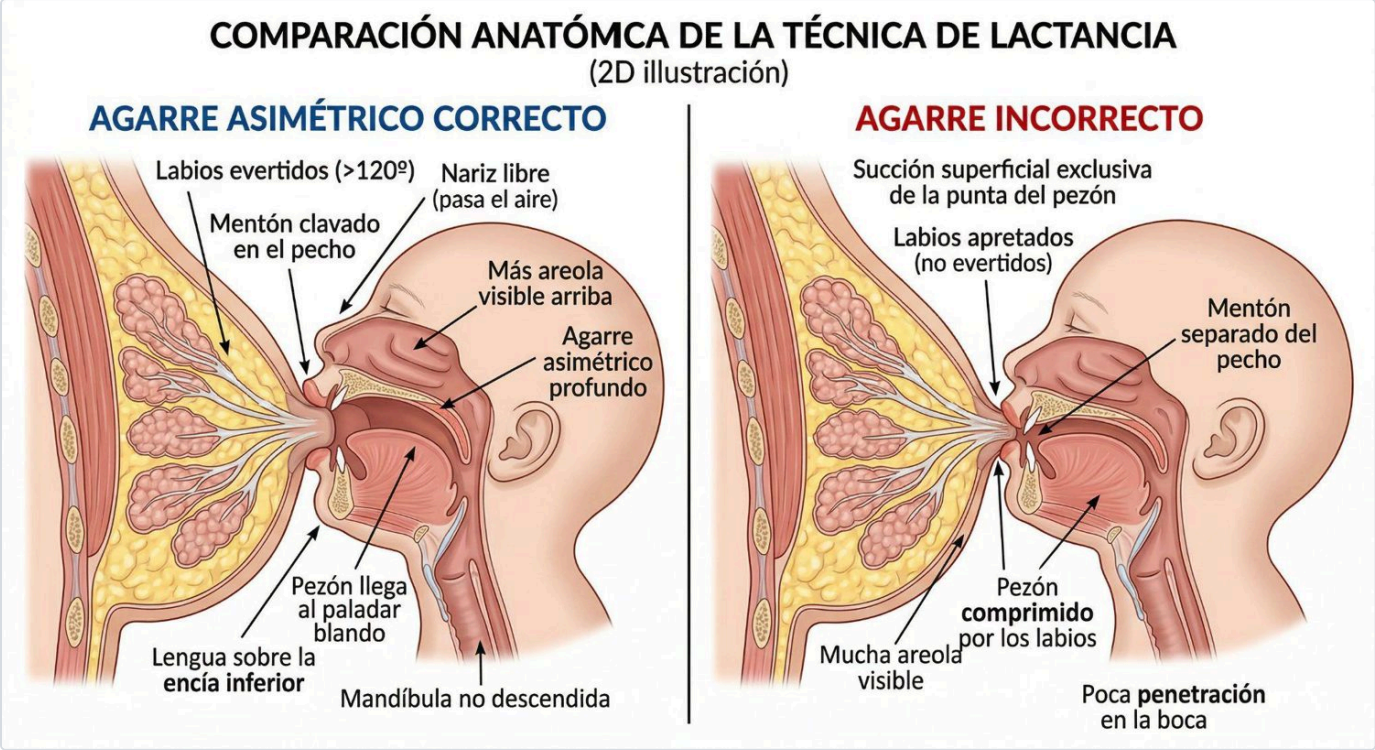
! Útero **desviado a la derecha** tras el parto = **globo vesical**.

! Sangrado con útero **contraído** = **trauma** (desgarro).

! **Mastitis: no se suspende la lactancia.**

! **Placenta previa: sangre roja, indolora, útero blando, sin tacto vaginal; desprendimiento: dolor + hipertonía y sangre oscura.**

Imágenes clave del tema



Agarre correcto e incorrecto en la lactancia materna